BUKU SAKU PENDIDIKAN KESEHATAN

MENCEGAH BAHAYA HIV/AIDS

Kesehatan, Penalaran Kritis, dan Empati Sosial

Pendekatan Problem-Based Learning (PBL) untuk Remaja

★ ★ ★ ★ ★

```
// Enam Sub-Materi Pembelajaran

I.   Konsep Dasar HIV/AIDS
II.  Fakta vs Mitos
III. Dampak HIV/AIDS
IV.  Strategi Pencegahan (PHBS)

// Empati, Non-Diskriminasi, dan Peran Remaja
```

Rahmat Irnandi, S.Or.

Pendidikan Kesehatan dan Olahraga

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku saku ini disusun sebagai pendamping belajar **Pendidikan Kesehatan** bagi remaja SMA/SMK, khususnya untuk memahami dan mencegah bahaya **HIV/AIDS** — salah satu tantangan kesehatan paling serius yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–24 tahun) menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap infeksi HIV baru. Kerentanan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh *rendahnya pengetahuan*, *mitos yang beredar*, dan *stigma sosial* yang membuat banyak remaja enggan mencari informasi dan bantuan.

Buku saku ini dirancang dengan pendekatan **Problem-Based Learning (PBL)** — sebuah model pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik tolak belajar. Setiap bab mengajak pembaca tidak sekadar menghafal fakta, tetapi **berpikir kritis**, **menganalisis kasus**, dan **mengambil keputusan** yang bertanggung jawab. Tujuannya bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peka secara sosial.

Enam sub-materi disusun berjenjang: dari konsep dasar, membedakan fakta dan mitos, memahami dampak multidimensi, menerapkan strategi pencegahan, menumbuhkan empati dan sikap non-diskriminatif, hingga memberdayakan remaja sebagai agen perubahan. Semua ini bermuara pada satu tujuan: *membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berempati.*

Akhir kata, semoga buku saku ini menjadi bekal bermakna untuk menjaga kesehatan diri, melindungi sesama, dan membangun lingkungan yang bebas stigma.

Indonesia, 2026

Rahmat Irnandi, S.Or.

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Langkah PBL untuk belajar aktif dan bermakna

BAGIAN INTI — MENCEGAH BAHAYA HIV/AIDS

Bab I **Konsep Dasar HIV/AIDS** 2
Pengertian, Penyebab, dan Cara Penularan

Bab II **Fakta vs Mitos** 5
Membedah Informasi yang Salah di Kalangan Remaja

Bab III **Dampak HIV/AIDS** 7
Fisik, Mental, Sosial, dan Ekonomi

Bab IV **Strategi Pencegahan** 9
PHBS dan Menghindari Perilaku Berisiko

Bab V **Empati dan Non-Diskriminasi** 11
Studi Kasus ODHA dan Cara Memberikan Dukungan

Bab VI **Peran Remaja sebagai Agen Perubahan** 14
Kampanye Pencegahan di Lingkungan Sekolah

— **Latihan Mandiri (Berbasis PBL)** 16
Empat skenario masalah untuk dipecahkan

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 17

— **Daftar Pustaka** 18

— **Profil Penyusun** 19

— **Penutup** 20

TIPS BELAJAR

Saat mempelajari HIV/AIDS, biasakan membuat *tabel dua kolom*: "Fakta" dan "Mitos". Ini akan melatih kemampuanmu memilah informasi yang benar dari hoaks yang beredar di media sosial — keterampilan yang sangat penting di era digital.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Ikuti lima langkah PBL berikut agar kamu dapat memahami materi Mencegah Bahaya HIV/AIDS secara mendalam dan bermakna.

I. Orientasi Masalah

Mulailah dengan membaca kasus atau skenario nyata di awal setiap bab. Bayangkan dirimu berada dalam situasi tersebut.

II. Rumuskan Pertanyaan

Setelah membaca kasus, ajukan pertanyaan: "Mengapa ini terjadi? Apa yang perlu aku ketahui untuk menyelesaikannya?"

III. Pelajari Materi

Gunakan uraian bab, tabel, dan callout untuk menjawab pertanyaanmu. Catat poin-poin penting.

IV. Diskusikan & Refleksikan

Gunakan ruang "Uji Nyali" di akhir bab untuk mendiskusikan solusi bersama teman atau guru.

V. Terapkan di Kehidupan Nyata

Hubungkan hasil belajar dengan perilaku sehari-hari: jaga kesehatan, lawan stigma, dan sebarkan informasi yang benar.

FOKUS UTAMA MATERI

Enam sub-materi inti: **(1) Konsep Dasar**, **(2) Fakta vs Mitos**, **(3) Dampak**, **(4) Pencegahan (PHBS)**, **(5) Empati & Non-Diskriminasi**, dan **(6) Peran Remaja** sebagai agen perubahan.

BAB

I

Konsep Dasar HIV/AIDS

Pengertian, Penyebab, dan Cara Penularan

BAB I: KONSEP DASAR

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 01**

- Menjelaskan perbedaan HIV dan AIDS secara tepat.
- Menguraikan cara kerja virus HIV di dalam tubuh manusia.
- Mengidentifikasi lima cara penularan HIV dan cara-cara yang *tidak* menularkan.

Peta Konsep Bab I

1. Pengertian → **2. Virus HIV** → **3. Cara Menular** → **4. Tidak Menular**

SKENARIO PBL PEMBUKA

Seorang siswa SMA berusia 16 tahun merasa cemas setelah membaca unggahan media sosial yang menyebut bahwa HIV bisa menular lewat gigitan nyamuk. Ia mulai menjauhi teman sekelasnya yang dikenal sebagai ODHA. **Pertanyaan:** Apakah kekhawatiran siswa tersebut berdasar? Apa yang seharusnya ia ketahui tentang HIV?

1. Pengertian HIV dan AIDS

Banyak orang menyamakan HIV dengan AIDS, padahal keduanya berbeda. **HIV** (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia — khususnya sel **CD4+** (sel T helper). Sementara itu, **AIDS** (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah **tahap akhir** dari infeksi HIV, ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah sehingga tubuh mudah terserang penyakit oportunistik.

Seseorang bisa **hidup bertahun-tahun dengan HIV** tanpa berkembang menjadi AIDS, asalkan rutin menjalani pengobatan *Antiretroviral Therapy* (ART). Dengan ART, jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan hingga *undetectable* — tidak terdeteksi — sehingga kualitas hidup penderita tetap baik dan risiko penularan menurun drastis.

DEFINISI KUNCI

HIV = virus penyebab melemahnya sistem kekebalan tubuh.
AIDS = kumpulan gejala penyakit akibat sistem imun yang rusak karena HIV.
ODHA = Orang dengan HIV/AIDS (istilah yang lebih menghargai, bukan "penderita").

2. Virus HIV dan Cara Kerjanya

Virus HIV menyerang sel CD4+ yang berperan sebagai "komandan" sistem kekebalan tubuh. Ketika sel ini dihancurkan, tubuh kehilangan kemampuan melawan infeksi. Prosesnya berlangsung perlahan:

1. **Infeksi awal:** Virus masuk ke aliran darah dan mulai menyerang sel CD4+.
2. **Fase akut (2–4 minggu):** Beberapa orang mengalami gejala mirip flu — demam, lelah, nyeri otot — yang sering disalahartikan sebagai penyakit biasa.
3. **Fase laten (bisa 8–10 tahun):** Virus terus berkembang biak secara diam-diam tanpa gejala berarti.
4. **Fase AIDS:** Kadar CD4+ turun drastis (di bawah 200 sel/mm³); muncul infeksi oportunistik seperti TBC, pneumonia, dan sarkoma Kaposi.

3. Lima Cara Penularan HIV

HIV menular melalui pertukaran **cairan tubuh tertentu** yang mengandung virus dalam jumlah cukup, yaitu: darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu (ASI). Ada lima jalur utama penularan:

1. HUBUNGAN SEKSUAL TIDAK AMAN

Hubungan seksual tanpa kondom (baik heteroseksual maupun sesama jenis) merupakan jalur penularan **tertinggi** di dunia, termasuk di Indonesia.

2. TRANSFUSI DARAH

Menerima darah atau organ dari donor yang terinfeksi HIV. Risiko ini sudah sangat ditekan melalui skrining darah di PMI.

3. JARUM SUNTIK BERGANTIAN

Penggunaan jarum suntik bersama (narkoba suntik, tato, tindik) yang tidak steril. Ini jalur penularan yang sangat efisien.

4. IBU KE ANAK

Selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Risiko dapat diturunkan hingga <2% dengan pengobatan ARV pada ibu hamil.

5. PAPARAN PETUGAS KESEHATAN

Tertusuk jarum atau terpapar darah pasien HIV tanpa alat pelindung diri (APD). Risiko ini relatif kecil (<0,3%).

CATATAN PENTING

Semua jalur di atas melibatkan **pertukaran cairan tubuh**. Tanpa itu, HIV tidak dapat menular.

4. Yang TIDAK Menularkan HIV

Banyak mitos beredar tentang penularan HIV. Faktanya, HIV **tidak menular** melalui aktivitas sosial sehari-hari berikut:

Aktivitas	Status
Jabat tangan, berpelukan, cium pipi	**Tidak menularkan**
Gigitan nyamuk atau serangga	**Tidak menularkan**
Makan dan minum bersama	**Tidak menularkan**
Berenang di kolam yang sama	**Tidak menularkan**
Toilet, kamar mandi, atau pegangan pintu	**Tidak menularkan**
Bersin, batuk, atau air liur	**Tidak menularkan**
Keringat, air mata, atau urin	**Tidak menularkan**

RINGKASAN BAB I

HIV = virus; **AIDS** = tahap akhir. **Penularan** hanya melalui pertukaran cairan tubuh: darah, air mani, cairan vagina, ASI. **Tidak menular** melalui jabat tangan, nyamuk, atau aktivitas sosial sehari-hari.

UJI NYALI BAB I — 01

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara HIV dan AIDS dengan bahasamu sendiri!
2. Mengapa gigitan nyamuk *tidak* dapat menularkan HIV? Jelaskan secara biologis!

BAB

II

Fakta vs Mitos HIV/AIDS

Membedah Informasi yang Salah di Kalangan Remaja

BAB II: FAKTA VS MITOS

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 02**

- Mengidentifikasi mitos-mitos populer tentang HIV/AIDS di kalangan remaja.
- Membedakan informasi palsu dengan fakta ilmiah berbasis sumber terpercaya.
- Mengembangkan kebiasaan memverifikasi informasi kesehatan sebelum membagikannya.

SKENARIO PBL PEMBUKA

Di grup WhatsApp kelas, beredar pesan berantai: *"Jangan dekat-dekat sama anak yang HIV-positif, nanti ketularan lewat keringat!"* Beberapa temanmu langsung percaya dan menjauh. **Pertanyaan:** Bagaimana kamu merespons pesan ini? Informasi apa yang kamu butuhkan untuk meluruskan?

1. Mengapa Mitos Mudah Beredar?

Mitos tentang HIV/AIDS mudah menyebar karena tiga faktor: **(1) rasa takut** yang berlebihan, **(2) kurangnya literasi kesehatan**, dan **(3) penyebaran hoaks lewat media sosial**. Ketika informasi yang benar tidak mudah diakses, orang cenderung mempercayai apa pun yang terdengar meyakinkan. Karena itu, kemampuan memilah fakta dan mitos menjadi keterampilan hidup yang wajib dimiliki remaja.

2. Tabel Mitos vs Fakta

Mitos (Salah)	Fakta (Benar)
"HIV menular lewat jabat tangan atau pelukan."	HIV tidak menular melalui sentuhan kulit. Virus tidak dapat menembus kulit utuh.
"Nyamuk bisa menularkan HIV."	Virus HIV tidak dapat bertahan hidup di tubuh nyamuk dan tidak bereplikasi di sana.
"HIV menular lewat alat makan bersama."	Air liur mengandung virus dalam jumlah sangat kecil — tidak cukup untuk menular.
"ODHA tidak boleh bersekolah atau bekerja."	ODHA berhak hidup normal. HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari.
"HIV hanya menyerang orang dengan perilaku tertentu."	HIV bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia, gender, atau status sosial.
"HIV bisa disembuhkan total dengan ramuan herbal."	Belum ada obat yang menyembuhkan HIV. Namun, ARV dapat mengendalikan virus.
"HIV ditularkan melalui berenang di kolam umum."	Air kolam mengencerkan virus, dan klorin membunuhnya. Tidak ada risiko penularan.
"Tes HIV berarti tanda seseorang 'nakal'."	Tes HIV adalah langkah bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain.

3. Cara Verifikasi Informasi Kesehatan

1. **Cek sumbernya:** Apakah berasal dari Kemenkes, WHO, atau lembaga resmi lain?
2. **Cek tanggal:** Informasi kesehatan bisa kedaluwarsa jika sudah lama.
3. **Bandingkan:** Cocokkan dengan minimal dua sumber kredibel lain.
4. **Waspadai judul sensasional:** "Bahaya!", "Sebelum Terlambat!", atau klaim tanpa data biasanya hoaks.
5. **Jangan langsung bagikan:** Tahan diri sebelum meneruskan pesan berantai yang belum terverifikasi.

BAB

III

Dampak HIV/AIDS

Fisik, Mental, Sosial, dan Ekonomi

BAB III: DAMPAK HIV/AIDS

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 03**

- Menganalisis dampak HIV/AIDS pada aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
- Memahami bagaimana dampak tersebut memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat.
- Mengembangkan empati berbasis pemahaman dampak multidimensional.

SKENARIO PBL PEMBUKA

Seorang remaja berusia 17 tahun baru saja dinyatakan HIV-positif. Ia dikeluarkan dari sekolah karena tekanan orang tua murid lain, dan ayahnya kehilangan pekerjaan setelah kondisi anaknya tersebar. **Pertanyaan:** Dampak apa saja yang dialami remaja ini? Siapa yang bertanggung jawab atas situasi tersebut?

1. Dampak Multidimensional HIV/AIDS

HIV/AIDS bukan hanya persoalan medis. Dampaknya merambat ke berbagai aspek kehidupan — dan ironisnya, *stigma* sering kali lebih merusak daripada virus itu sendiri.

Aspek	Dampak pada Individu	Dampak pada Keluarga & Masyarakat
Fisik	Penurunan imunitas, infeksi oportunistik, kelelahan kronis, penurunan berat badan.	Beban perawatan; meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan.
Mental	Cemas, depresi, rasa bersalah, kehilangan harapan, risiko bunuh diri.	Konflik keluarga; kelelahan emosional pengasuh.
Sosial	Dikucilkan, kehilangan teman, putus sekolah, sulit mendapat pekerjaan.	Stigma komunitas, diskriminasi di fasilitas umum, keretakan sosial.
Ekonomi	Biaya pengobatan seumur hidup, kehilangan produktivitas, kehilangan pekerjaan.	Kemiskinan keluarga, beban APBN untuk layanan kesehatan.

2. Stigma: Dampak yang Sering Diabaikan

Stigma adalah pelabelan negatif terhadap seseorang karena kondisi tertentu. Pada HIV/AIDS, stigma sering berbentuk pengucilan, gosip, penolakan sosial, bahkan kekerasan. Banyak ODHA **takut mengungkapkan statusnya** karena khawatir kehilangan pekerjaan, teman, atau keluarga. Akibatnya, mereka enggan berobat — yang justru memperburuk kesehatan dan memperbesar risiko penularan.

DATA KUNCI

UNAIDS mencatat bahwa **stigma dan diskriminasi** menjadi salah satu penghalang terbesar dalam upaya mengakhiri epidemi AIDS pada 2030. Mengurangi stigma sama pentingnya dengan menyediakan obat.

DAMPAK STIGMA

ODHA menyembunyikan status → enggan tes dan berobat → kesehatan memburuk → risiko penularan meningkat.

SOLUSI

Edukasi publik yang benar → empati dan dukungan sosial → ODHA berani berobat → epidemi terkendali.

RINGKASAN BAB III

BAB

IV

Strategi Pencegahan

PHBS dan Menghindari Perilaku Berisiko

BAB IV: STRATEGI PENCEGAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 04**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.
- Mengidentifikasi perilaku berisiko tinggi dan cara menghindarinya.
- Memahami pentingnya tes HIV sukarela (VCT) sebagai langkah preventif.

SKENARIO PBL PEMBUKA

Seorang siswa kelas XI mulai menggunakan narkoba suntik dan sering berganti pasangan. Ia merasa "tidak mungkin kena HIV" karena masih muda dan sehat. **Pertanyaan:** Apa saja perilaku berisiko yang ia lakukan? Bagaimana kamu bisa membantunya berubah sebelum terlambat?

1. Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

PHBS bukan sekadar mencuci tangan. Dalam konteks pencegahan HIV/AIDS, PHBS mencakup gaya hidup yang menjauhkan diri dari perilaku berisiko tinggi dan memperkuat kesehatan tubuh secara menyeluruh.

1. JAGA KEBERSIHAN DIRI

Cuci tangan dengan sabun, mandi teratur, jaga kebersihan alat pribadi (sikat gigi, pisau cukur, jarum tindik).

2. HIDUP AKTIF & SEIMBANG

Olahraga rutin, tidur cukup, konsumsi gizi seimbang untuk memperkuat imunitas tubuh.

3. HINDARI ROKOK & NARKOBA

Narkoba suntik adalah salah satu jalur penularan HIV utama. Hindari sepenuhnya.

4. KELOLA STRES SEHAT

Kesehatan mental yang baik membantu remaja mengambil keputusan rasional, termasuk menolak tekanan teman.

2. Strategi ABCDE Pencegahan HIV

1. **A — Abstinence:** Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah.
2. **B — Be Faithful:** Setia pada satu pasangan yang sah.
3. **C — Condom:** Gunakan kondom jika berisiko; ini bukan dorongan perilaku bebas, tetapi langkah pengurangan risiko.
4. **D — Don't Share Needles:** Jangan berbagi jarum suntik, alat tato, atau tindik.
5. **E — Education:** Pendidikan kesehatan yang benar adalah senjata utama.

3. Tes HIV Sukarela (VCT)

VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) adalah layanan tes HIV yang bersifat **sukarela, rahasia, dan disertai konseling**. Tes ini tersedia gratis di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Mengetahui status lebih awal memungkinkan pengobatan dini dan mencegah penularan kepada orang lain.

PENTING DIKETAHUI

Tes HIV **bukan tanda seseorang "nakal"**. Tes HIV adalah tindakan *bertanggung jawab* — sama seperti memeriksakan tekanan darah atau gula darah. Semua orang yang pernah berisiko dianjurkan tes.

UJI NYALI BAB IV — **04**

1. Sebutkan lima strategi ABCDE pencegahan HIV dan berikan contoh penerapannya di kehidupan

BAB

V

Empati dan Non-Diskriminasi

Studi Kasus ODHA dan Cara Memberikan Dukungan

BAB V: EMPATI & NON-DISKRIMINASI

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 05**

- Menganalisis pengalaman hidup ODHA melalui studi kasus.
- Memahami dampak stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
- Merumuskan cara memberikan dukungan yang tepat tanpa memberi stigma.

SKENARIO PBL PEMBUKA

Seorang siswi bernama *Nia* (17 tahun) baru saja menerima hasil tes HIV-positif. Ia terinfeksi dari transfusi darah saat operasi kecil beberapa tahun lalu. Ia takut kehilangan teman, dikeluarkan dari sekolah, dan dianggap "kotor". **Pertanyaan:** Apa yang seharusnya dilakukan teman-teman Nia? Bagaimana kamu akan merespons jika Nia adalah teman sebangkumu?

1. Apa Itu Stigma dan Diskriminasi?

Stigma adalah pelabelan negatif berdasarkan prasangka. **Diskriminasi** adalah tindakan nyata yang merugikan seseorang karena label tersebut — misalnya menolak duduk sebelah, mengeluarkan dari sekolah, atau memecat dari pekerjaan. Keduanya saling berkaitan dan sama-sama berbahaya.

Banyak ODHA di Indonesia **menyembunyikan statusnya** bukan karena takut mati, tetapi karena takut *dikucilkan*. Padahal, isolasi sosial memperburuk kondisi mental mereka dan membuat mereka enggan berobat.

2. Studi Kasus: Perjalanan Seorang ODHA

KISAH NYATA (NAMA DISAMARKAN)

Pak Andi (38 tahun) terinfeksi HIV dari transfusi darah pada 2014. Setelah statusnya diketahui, ia kehilangan pekerjaan, ditinggalkan sebagian teman, dan hampir bunuh diri. Namun, dengan dukungan komunitas ODHA dan keluarga, ia bangkit kembali. Kini ia menjadi *peer educator* yang aktif mengedukasi remaja tentang HIV/AIDS. *"Yang membunuh saya bukan virusnya, tetapi perlakuan orang-orang di sekitar saya,"* katanya.

Kisah Pak Andi menunjukkan bahwa **dukungan sosial adalah "obat" yang tak kalah penting** dari obat medis. ODHA yang diterima lingkungannya lebih disiplin berobat, lebih sehat secara mental, dan lebih produktif.

3. Mengapa Empati Penting?

UNTUK ODHA

ODHA yang diterima merasa aman untuk berobat rutin dan terbuka. Kualitas hidupnya meningkat.

UNTUK MASYARAKAT

Epidemi lebih mudah dikendalikan karena ODHA berani tes dan berobat. Penularan menurun.

UNTUK KITA SENDIRI

Empati melatih kematangan emosional dan memperkuat karakter sebagai warga negara yang beradab.

UNTUK SEKOLAH

Lingkungan yang inklusif mencegah bullying dan menciptakan budaya saling mendukung.

4. Bahasa yang Ramah dan Tidak Menstigma

Kata-kata memiliki kekuatan. Cara kita berbicara tentang HIV/AIDS bisa menyembuhkan atau melukai. Gunakan bahasa yang **berpusat pada manusia**, bukan pada penyakitnya.

Hindari (Menstigma)	Gunakan (Ramah)
"Penderita HIV" / "pengidap HIV"	**Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)**
"Si AIDS" / "si HIV"	Nama orang tersebut — mereka bukan penyakitnya.
"Menularkan" (menyalahkan)	"Tertular" (fokus pada kondisi, bukan menyalahkan)
"Korban HIV"	ODHA / orang yang hidup dengan HIV
"Grup risiko tinggi"	"Perilaku berisiko tinggi"

5. Cara Memberikan Dukungan Konkret

1. **Jangan menjauhi:** Tetap berteman seperti biasa. HIV tidak menular lewat interaksi sosial.
2. **Jaga kerahasiaan:** Jangan membagikan status HIV temanmu ke orang lain tanpa izinnya.
3. **Dengarkan tanpa menghakimi:** Kadang ODHA hanya butuh didengar, bukan dinasihati.
4. **Bantu akses layanan:** Dampingi ke puskesmas atau komunitas ODHA jika ia kesulitan.
5. **Lawan ujaran kebencian:** Tegur dengan sopan jika ada yang menyebar mitos atau merendahkan ODHA.
6. **Edukasi diri sendiri:** Semakin kamu paham, semakin kecil kemungkinan tanpa sadar mendiskriminasi.

6. Hak-Hak ODHA di Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas **menjamin hak ODHA**: berobat, bersekolah, bekerja, menikah, dan hidup bermasyarakat tanpa diskriminasi.

> **REFLEKSI KONSTITUSIONAL**
>
> Pasal 28A–28J UUD 1945 menjamin hak hidup, bebas dari diskriminasi, dan pengembangan diri. ODHA adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan kita semua.

UJI NYALI BAB V — 05

1. Ubah kalimat berikut menjadi bahasa yang ramah ODHA: *"Banyak korban HIV di kampung ini yang tertular karena nakal."*
2. Sebutkan tiga cara konkret untuk mendukung teman ODHA di sekolahmu!

BAB

VI

Peran Remaja sebagai Agen Perubahan

Kampanye Pencegahan HIV/AIDS di Lingkungan Sekolah

BAB VI: REMAJA AGEN PERUBAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 06**

- Menjelaskan peran strategis remaja dalam pencegahan HIV/AIDS.
- Merancang kampanye pencegahan HIV/AIDS di sekolah (berbasis PBL).
- Mengembangkan keterampilan advokasi dan komunikasi publik.

SKENARIO PBL PEMBUKA

Kepala sekolahmu memintamu memimpin kampanye "Sekolah Peduli HIV/AIDS" selama satu semester. Dana terbatas, waktu terbatas, dan sebagian guru masih percaya mitos. **Pertanyaan:** Bagaimana kamu akan merancang kampanye yang berdampak?

1. Mengapa Remaja Kunci?

Remaja adalah kelompok yang paling rentan sekaligus **paling strategis**. Rentan karena masih dalam fase pencarian identitas dan rentan terhadap tekanan teman. Strategis karena remaja paling mudah menjangkau teman sebayanya melalui bahasa yang sama, media yang sama, dan gaya yang sama. Inilah kekuatan **peer education** (pendidikan sebaya).

2. Empat Peran Utama Remaja

1. EDUKATOR SEBAYA

Membagikan informasi HIV/AIDS yang benar kepada teman, keluarga, dan komunitas.

2. TELADAN PERILAKU

Menjalankan PHBS, menolak narkoba, dan menghindari perilaku berisiko dalam keseharian.

3. KREATOR KAMPANYE

Membuat konten kreatif (poster, video, infografis, podcast) di media sosial.

4. PEMBELA NON-DISKRIMINASI

Menjadi suara yang melindungi ODHA dari stigma dan bullying di sekolah.

3. Ide Kampanye di Sekolah

1. **Pekan Peduli HIV/AIDS:** Pameran poster, pembagian pita merah (red ribbon), dan talkshow bersama tenaga kesehatan.
2. **Kelas Sebaya:** Sesi diskusi rutin dipandu siswa terlatih (peer counselor) untuk membahas HIV/AIDS secara terbuka.
3. **Kampanye Media Sosial:** Buat konten edukatif di Instagram, TikTok, atau YouTube sekolah dengan tagar kreatif.
4. **Lomba Kreatif:** Poster, video pendek, atau esai bertema "Remaja Sehat, Bebas Stigma".
5. **Kolaborasi dengan Puskesmas:** Undang tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan layanan tes VCT sukarela.
6. **Deklarasi Sekolah Ramah ODHA:** Membuat komitmen bersama anti-stigma yang ditandatangani seluruh warga sekolah.

KIAT SUKSES KAMPANYE

Kampanye yang berhasil bukan yang paling ramai, tetapi yang **paling mengubah perilaku**. Fokus pada pesan yang jelas, mudah diingat, dan relevan dengan kehidupan remaja.

LATIHAN MANDIRI (PBL)

Setelah mempelajari seluruh materi, kerjakan empat skenario masalah berikut. Diskusikan dalam kelompok kecil, lalu presentasikan solusimu!

SKENARIO 1 — ANALISIS MITOS

Beredar pesan di media sosial: "HIV bisa menular lewat keringat saat olahraga bersama." Sebagai ketua OSIS, kamu diminta merespons. Identifikasi mitosnya, jelaskan faktanya, dan rancang respons yang tepat!

SKENARIO 2 — DAMPAK MULTIDIMENSIONAL

Seorang siswa dikeluarkan dari sekolah setelah status HIV-positifnya tersebar. Analisis dampak fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang dialaminya. Apa yang seharusnya dilakukan sekolah?

SKENARIO 3 — STRATEGI PENCEGAHAN

Temanmu mulai mencoba narkoba dan sering bergaul dengan kelompok berisiko. Rancang strategi komunikasi persuasif untuk membantunya berubah tanpa menceramahi!

SKENARIO 4 — KAMPANYE SEKOLAH

Rancang proposal kampanye "Sekolah Ramah ODHA" selama satu bulan. Sertakan tujuan, sasaran, kegiatan, anggaran sederhana, dan indikator keberhasilan!

TIPS DISKUSI PBL

Gunakan alur: **identifikasi masalah → rumuskan pertanyaan → cari informasi → usulkan solusi → evaluasi solusi**. Catat setiap langkah agar mudah dipresentasikan.

KAMUS ISTILAH

Daftar istilah penting seputar HIV/AIDS dan pencegahannya.

HIV
Human Immunodeficiency Virus; virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome; tahap akhir infeksi HIV ketika imunitas sangat lemah.

ODHA
Orang dengan HIV/AIDS; istilah yang lebih menghargai dibanding "penderita".

CD4+
Sel T helper yang menjadi target utama HIV; jumlahnya menurun seiring progresivitas infeksi.

ART / ARV
Antiretroviral Therapy; obat yang menekan replikasi HIV dan menjaga imunitas.

Undetectable
Kondisi ketika jumlah virus dalam darah sangat rendah sehingga tidak terdeteksi; risiko penularan sangat kecil.

VCT
Voluntary Counseling and Testing; layanan tes HIV sukarela disertai konseling.

Infeksi Oportunistik
Penyakit yang menyerang ketika imunitas lemah, misalnya TBC atau pneumonia.

PHBS
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; gaya hidup yang menjaga kesehatan fisik dan mental.

Stigma
Pelabelan negatif terhadap seseorang karena kondisi tertentu, misalnya HIV.

Diskriminasi
Tindakan merugikan seseorang karena label atau status tertentu.

Peer Education
Pendidikan sebaya; model belajar di mana remaja mendidik remaja lain.

Red Ribbon
Pita merah; simbol solidaritas global untuk ODHA dan kampanye HIV/AIDS.

Mitos
Kepercayaan yang beredar luas namun tidak memiliki dasar ilmiah.

Hoaks
Informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan.

PBL
Problem-Based Learning; model pembelajaran berbasis masalah nyata.

PrEP
Pre-Exposure Prophylaxis; obat pencegahan HIV sebelum terpapar virus, untuk kelompok berisiko tinggi.

PEP
Post-Exposure Prophylaxis; obat darurat setelah terpapar HIV, harus diminum <72 jam.

Transmisi Vertikal
Penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

UNAIDS
Badan PBB yang menangani epidemi HIV/AIDS global.

Epidemi
Penyebaran penyakit yang cepat dan luas di suatu populasi.

Inklusif
Bersifat terbuka dan menerima semua orang tanpa membedakan status.

Advokasi
Upaya mempengaruhi kebijakan atau opini publik untuk perubahan positif.

Screening
Pemeriksaan awal untuk mendeteksi penyakit pada orang yang tampak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan buku saku ini.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Triwulan IV Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV*. Jakarta: Kemenkes RI.

World Health Organization. (2023). *HIV/AIDS Fact Sheet*. Geneva: WHO.

UNAIDS. (2023). *Global HIV & AIDS Statistics — Fact Sheet*. Geneva: UNAIDS.

UNAIDS. (2021). *Ending Inequalities: A Global AIDS Strategy 2021–2026*. Geneva: UNAIDS.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/SMK*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kemenkes RI.

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. (2019). *Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2020–2024*. Jakarta: KPAN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Panduan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN.

Hull, T. H., & Hasmi, E. (2019). *HIV/AIDS in Indonesia: A Review of the Epidemiology, Policy, and Programmatic Response*. Jakarta: World Bank.

Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

CATATAN SUMBER

Rujukan di atas merupakan sumber utama dalam perumusan materi. Tabel, refleksi, dan skenario PBL disusun ulang dengan bahasa yang disesuaikan untuk siswa SMA/SMK.

PROFIL PENYUSUN

Rahmat Irnandi, S.Or.

Pendidik Pendidikan Kesehatan & Olahraga

Penulis adalah pendidik di bidang **Pendidikan Kesehatan dan Olahraga** yang berfokus pada upaya membangun generasi muda yang sehat, bugar, dan peduli sesama. Ia meyakini bahwa kesehatan bukan hanya soal terbebas dari penyakit, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan bijak, dan memiliki empati sosial.

Ketertarikannya pada isu HIV/AIDS berawal dari pengalaman mendampingi remaja yang terdampak stigma sosial. Ia menyadari bahwa **pengetahuan yang benar** dan **lingkungan yang mendukung** adalah kunci utama pencegahan. Buku saku ini disusun sebagai wujud kepedulian tersebut.

Melalui karya ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam membentuk remaja Indonesia yang **melek kesehatan**, berani menolak mitos, dan siap menjadi agen perubahan di lingkungannya.

> *"Melawan HIV/AIDS bukan sekadar melawan virus, tetapi juga melawan ketidaktahuan dan stigma. Remaja adalah ujung tombak kedua perjuangan itu."*
>
> — RAHMAT IRNANDI, S.OR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh siswa, rekan pendidik, tenaga kesehatan, dan komunitas peduli HIV/AIDS yang telah menginspirasi penyusunan buku saku ini. Semoga menjadi langkah kecil untuk perubahan yang bermakna.

★ ★ ★

Mencegah Bahaya HIV/AIDS

Kesehatan, Penalaran Kritis, dan Empati Sosial

"Remaja yang sehat bukan hanya yang terbebas dari penyakit,
tetapi yang berani berkata tidak pada perilaku berisiko,
dan berani merangkul mereka yang dikucilkan."

Enam sub-materi telah kita pelajari:
konsep dasar, fakta vs mitos, dampak, pencegahan, empati, dan peran remaja.

Jadilah remaja yang melek kesehatan — pahami faktanya, lawan stigmanya, dan sebarkan kebaikannya.

★ ★ ★